EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 80556
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 13-03-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: SERGIO IVAN BERNALES BUSTOS			RUN	: 8.768.137-8
F.Nac	: 10-11-1959	Edad	: 64 AÑOS, 4 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: LAS ALITAS DEL CARBON			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-03-11	Fecha Egreso	: 13-03-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Neumonía Adquirida en la comunidad
AP: HDA por Ulcera gástrica, DHC Child B

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. R50.9-FIEBRE, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente refiere inicio de sintomatología hace 2 días presentando episodio febril cuantificado en ingreso en 39.8°C, asociado a compromiso de consciencia (Somnolencia). Durante interrogatorio dirigido el paciente únicamente destaca leve dolor en región hipogástrica asociado a leve dolor en región cervical central no asociado a disfagia. Niega nauseas, vómitos, mareos, diarrea, tos, expectoración o algún otro signo o síntoma asociado. Durante estanca hospitalaria se toman exámenes de laboratorio donde destaca procalcitonina 1.21, PCR 32, GB 16, Crea 1.0, Glicemia 131. Radiografía impresiona patrón de predominio periférico, infiltrativo-congestivo(¿). Destaca aumento de volumen leve en pierna izquierda asociado a franca dermatitis por éstasis con descamación y enrojecimiento circundante leve. Ex físico Piel: cambios y signos propios de la edad. Buen llenado capilar. CP: torax asimétrico, hipoexpansible, crepitos aislados base derecha, RSCSRSRS SS NG Abd: distendido a expensas de panículo adiposo, globoso, RHA+, no doloroso a la palpación. Neurológico: hipoacusia, consciente, orientado en tiempo espacio y persona, sin signos de focalización o irritación meníngea.
Tac de Torax : sin Hallazgo de significado Patológico
Tac de Abdomen y Pelvis: Hernia Umbilical no Complicada. -Quiste Hepático.-Aumento De volumen Prostático.
Eco Doppler sin evidencia de trombosis venosa profunda. – edema difuso celular subcutáneo sin colección. Urocultivo negativo.
Sin fiebre durante la hospitalización. Hemodinamia estable, hidratado, a febril, hidratado,

yugulares planas, torax mp presente , expansible, agregados crépitos finos , rr2ts, abdomen globoso, blando rha presente no doloroso, eeii sin edema, neurologico vigil orientado glagsow 15 ptos . en condiciones de alta.

PLAN DE MANEJO:

Regimen diabético
Omeprazol 20mg vo día
Ceftriaxona 2gr ev día por 7 dias
Paracetamol 1gr vo cada 8 horas sos
B. ipratropio 2 puff c8h por 7 dias
Losartan 50mg vo día
Tamsulosina 0.4mg vo día
Furosemida 20mg vo cada 12h

INDICACIONES AL ALTA

1. Hospitalizar en HODOM
2. Infeccioso: mantener tto atb- rescatar hemeocultivo.
3. Control Medicina Interna en 21 dias

Control en: 21 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO